

Gestire problematiche di erogazione nonostante la presenza di ossigeno

Flusso assente o molto ridotto

Cosa riferisce il paziente

- “Il contenitore non eroga bene.”
- “Flusso assente o debole”.
- “Bollicine nel gorgogliatore assenti / ridotte / presenti ma poco evidenti”

Porre sempre la domanda “Fa le bollicine nel bicchiere trasparente? Il gorgogliatore?.”

NB: Si parla di malfunzionamento, quindi si ha già la certezza che ci sia ancora ossigeno nel contenitore, quindi, sono già stati effettuati i controlli sull'indicatore di livello.

Verifica immediata del flusso

Manopola di regolazione del flusso



- Controllare che sia esattamente sul numero della terapia prescritta.
- Se la manopola è posizionata sullo 0 il contenitore non eroga.
- Se è tra due numeri, il flusso può non uscire correttamente → riposizionare.

Se risolto → rassicurare il paziente. Se non risolto → passare al punto successivo.

Indicatore di pressione (se presente)

Tipo 1

Indica la pressione all'interno del contenitore: la lancetta deve stare nella striscia blu.
(Tra 1.0 e 2.1)

Ago nella striscia blu = pressione ok.

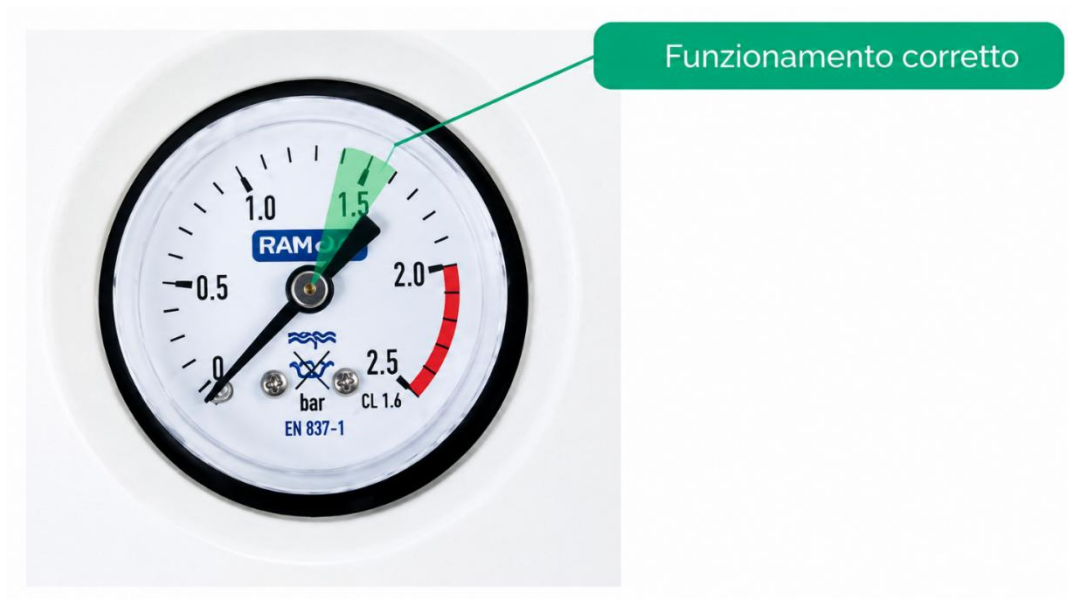
- ≤ 1 = bassa pressione → contenitore da sostituire.
- ≥ 2.1 = pressione alta → contenitore da sostituire.



Tipo 2

Durante il normale funzionamento la pressione indicata deve essere compresa tra circa 1,4 e 1,6 bar

Se supera 1,6 bar o è inferiore a 1,4 bar il contenitore è da sostituire



Se la pressione è corretta → avanti con le prove.

In caso di contenitore appena consegnato e caricato di recente, verificare il tempo trascorso dalla consegna.

Il contenitore potrebbe non aver ancora raggiunto la pressione di esercizio necessaria. *Attendere circa due ore dal caricamento* per consentire il ripristino della corretta pressione.

Verifica dei collegamenti



1) Connettore / farfallina dell'umidificatore

Controllare che il connettore tra tappo del gorgogliatore e rubinetto di erogazione (Gruppo riduttore) sia ben serrato. Se non risolto → proseguire.

2) Gorgogliatore / Umidificatore

Far verificare al paziente:

- Gorgogliatore ben avvitato (invitare il paziente a svitare e riavvitare). Se non fosse avvitato perfettamente il flusso potrebbe diminuire o essere assente per fuoriuscita di Ossigeno. La bollicine possono diminuire o essere assenti
- Verificare che non ci sia nessuna rottura/spaccatura. Nel caso ci fosse il flusso potrebbe diminuire o essere assente per fuoriuscita di Ossigeno. La bollicine possono diminuire o essere assenti
- Assicurarsi che non ci sia nessun accumulo di calcare in alcuna parte del gorgogliatore. Il calcare può ostacolare il flusso di O₂ che non arriva al paziente adeguatamente.

- Acqua tra minimo e massimo (troppa acqua = flusso ostacolato). Ps: poca acqua poca umidificazione.

Se rotto

- Usare quello di riserva.
- Organizzare consegna per garantire sempre 2 gorgogliatori disponibili.

Se non ne ha → consegna urgente.

3) Cannula

Verificare che sia ben collegata.

- Non sia piegata, schiacciata o incastrata sotto mobili.
- Non presenti fori o usura.
- Sia integra e non ostruita.

Se risolto → rassicurare.

Cannula integra ma problema ancora presente → procedere con le altre prove.

Cannula rotta → usare quella di riserva + consegna per garantire sempre 2 cannule (o consegna urgente se manca la scorta).

Test del bicchiere

Far immergere la punta (nasellini) della cannula in un bicchiere d'acqua.

- Bollicine presenti → il contenitore eroga.
- Nessuna bollicina → possibile problema di pressione o erogazione.

Test pressione

Ricarica del portatile.

Provare a caricare il contenitore portatile dalla sorgente madre.

- Se non si carica o si carica molto lentamente, la pressione del contenitore principale può essere insufficiente.
-

Se il problema persiste

Se nessuna prova risolve → contattare il vettore per consegna/sostituzione del contenitore.

Se il problema persiste, il paziente continua a sostenere di “ Non sentire l’Ossigeno” valutare una possibile farmacovigilanza.